7.7 감염성질환 환자관리			
규 정 번 호	7.7	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	7.7 감염성질환 환자관리	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	감염관리실, 간호부	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 의료법 시행규칙 제 43조, 제44조, 제46조 2. 의료관련 감염 표준예방지침		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 감염성질환자나 감염이 의심되는 환자로부터 다른 환자나 직원이 감염되거나 미생물이 전파 되는 것을 예방하기 위해 감염성질환의 유입을 차단한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 감염성질환 관리에 대한 규정이 있다.
2. 유행성 감염병 위기 상황 시 관리 절차를 준수한다.
3. 감염병 전파경로에 따른 절차를 준수하여 환자를 관리한다.

▣ 지침 및 절차

1. 전파경로에 따라 격리가 필요한 감염병 대상

가. 공기주의 : 활동성 결핵, 홍역, 수두, 파종성 대상포진 등

나. 비말주의 : 백일해, 유행성이하선염, 성홍열, 풍진, 수막구균 감염증 등

다. 접촉주의

1) 제2급감염병 : 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증, A형간염 등

2) 다제내성균 : VRE, CRE, VRSA(VISA 포함) 등

3) 그 외 : 옴, Clostridium difficile, 로타바이러스 등

라. 그 외 감염성 질환으로 인해 환자에게 전파의 위험이 있는 경우

마. 생물학적 테러나 새로운 감염질환으로 전파경로가 불확실한 경우

2. 유행성 감염병 위기 상황 시 외래환자 감염성 질환 관리

가. 유행성 감염병에 대한 최신 정보 공유 절차

1) 국가 및 관련 기관과의 정보 공유방법

가) 질병관리청의 해외여행력 정보제공 프로그램(ITS)으로 진료 전 환자의 해외여행력을 인지하여 감염병 노출을 차단한다.

(1) 본원 전자의무기록(EMR)의 DUR 시스템에 ITS 프로그램을 반영하여 접수 및 진료 시 해외여행력 확인한다.

(2) 본원 원무과 직원의 PC와, 진료실 의사의 PC에 ITS 프로그램을 다운받아 접수 및 진료 시 해외여행력을 확인한다.

나) 질병관리청 보도 참고 자료 및 주간 감염병 발생 동향을 통하여 유행성 감염병에 대한 현황을 파악한다.

다) 질병관리청 카카오톡 플러스친구를 통하여 유행성 감염병에 대한 정보를 공유한다.

2) 의료기관 내 정보 게시

가) 감염관리실에서는 질병관리청 주간 국내외 감염병 동향 자료를 해당 부서와 공유하기 위해 회보, 홈페이지, 게시판 등을 통해 정보를 게시한다.

나. 의심환자 선별

1) 의심환자 선별을 위한 안내문을 게시한다.
2) 원내 출입 통로를 차단하고 1층 후문 입구만을 유일한 통로로 한다.
3) 원내 진입 시 문진을 통해 역학적 연관성과 감염 의심 증상을 확인한다.
4) 문진을 통해 발열, 호흡기 증상(기침, 가래, 호흡곤란 등), 소화기 증상(복통, 설사 등) 등의 감염여부를 평가하고 감염의심 요인을 사정한다.
5) 출입대장 작성 후 원내 출입한다.

다. 감염전파 예방 수칙 준수

1) 환자 및 보호자를 대상으로 진료 절차, 주의사항을 안내한다.

가) 내용 : 진료 절차 및 주의사항(손위생 및 호흡기 예절) 안내

나) 방법 : 병원입구, 데스크 안내 등

2) [1.3 손위생 수행] 규정에 따라 손위생을 수행한다.
3) 전파경로에 따라 필요한 개인보호구를 착용한다.
4) 개인보호구는 착용법에 따라 올바르게 착용한다.

라. 호흡기 예절

1) 기침이나 재채기를 할 때 입과 코를 휴지로 가리고, 사용한 휴지는 바로 휴지통에 버리고, 휴지가 없다면 옷소매를 이용하도록 한다.
2) 마스크를 착용하고 다른 사람으로부터 고개를 돌려 기침이나 재채기를 하도록 한다.
3) 다른 환자와 1m 이상 거리를 유지한다.
4) 병원 입구와 눈에 잘 띄는 장소에 호흡기 예절과 관련한 포스터를 게시한다.
5) 대기 장소에는 손위생 관련한 물품을 제공한다.

마. 환자 이송방법

1) 환자 이송 시 준비 사항

가) 전파경로에 따라 필요한 개인보호구를 착용한다.

나) 환자는 마스크 착용, 직원 및 보호자는 KF94마스크를 착용한다.

다) 환자 이송 시 동선 관리

(1) 의심 환자가 인지된 구역의 폐쇄가 가능한 경우에는 환자, 보호자 이동을 제한하고 출입문을 폐쇄한다.

(2) 의심 환자가 인지된 구역의 폐쇄가 불가능한 경우에는 의심 환자 주변 2미터 이내에 대기하고 있는 환자, 보호자들의 이동을 제한한다.

(3) 가능한 다른 환자 및 직원들과 겹치지 않는 동선으로 이동한다.(엘리베이터는 2호기를 사용하여 이송)

(4) 해당 환자 이송 전 이송 도착 부서에 감염병 의심 상황 및 격리 정보를 유선 연락으로 전달하고, 도착 부서 확인 후 이송한다.

바. 노출 관리

1) 환경 관리

가) 환경 소독

(1) 의심 또는 확인된 유행성 감염병이 공기주의가 요구되는 호흡기질환인 경우, 2시간 이상 환기 후 소독티슈를 이용하여 청소 및 소독한다.

(2) 의심 또는 확인된 유행성 감염병이 공기주의가 요구되는 호흡기질환이 아닌 경우, 소독티슈를 이용하여 청소 및 소독한다.

(3) 육안으로 오염이 확인되면 즉시 청소 및 소독한다.

(4) 유행성 감염병 의심환자에게 사용한 물품은 비닐에 넣어 감염표시를 하고, 사용물품 전용용기에 담아 보관 후 세척소독실로 멸균 의뢰한다.

나) 의료폐기물 및 세탁물 처리

(1) 의료폐기물은 격리의료폐기물로 처리한다.

(2) 환자가 사용한 세탁물은 오염세탁물로 간주하고 [7.3 세척・소독・멸균 및 세탁물 관리] 규정에 따라 처리한다.

2) 환자 담당 의료진 감염예방 및 관리

가) 개인보호구 착용 : 감염성질환자의 진료에 참여하는 의료진은 감염 전파경로별 주의 지침에 해당하는 개인보호구를 착용한다.

나) 노출자 관리 : 직원은 감염 노출 시 [9.4 직원안전 관리활동] 규정에 따른다.

3. 전파경로에 따른 격리

가. 표준주의 : 방문하는 모든 환자, 보호자, 직원, 방문객 등을 대상으로 한다.

1) 손위생 : [1.3 손위생 수행] 규정에 따른다.

2) 개인보호구 착용

가) 사용원칙

(1) 혈액이나 체액이 튈 우려가 있을 경우 착용한다.

(2) 개인보호구를 벗는 과정에서 의복과 피부를 오염시키지 않도록 주의한다.

(3) 환자 병실을 떠나기 전에 개인보호구를 제거한다.

나) 장갑

(1) 혈액 혹은 잠재적인 감염물질, 점막, 손상된 피부, 혹은 배설물로 오염된 피부와 접촉할 경우 장갑을 착용한다.

(2) 환자나 환경 접촉 후 장갑을 제거한다. 장갑을 제거할 때 손이 오염되지 않도록 적절한 방법으로 제거한다. 환자마다 장갑을 교환하고 재사용하지 않는다.

(3) 한 환자에서 오염된 부위를 접촉 후 깨끗한 부위를 접촉하기 전 장갑을 교환한다.

다) 가운

(1) 환자의 혈액, 체액, 분비물, 배설물과 접촉을 예상할 경우 시술자의 피부를 보호하고 옷이 오염되는 것을 방지하기 위하여 방수용 가운을 착용한다.

(2) 동일한 환자를 반복해서 접촉할 경우라 하더라도 가운은 재사용하지 않는다.

라) 입, 코, 눈 보호

(1) 입, 코, 눈의 점막에 환자의 혈액, 체액, 분비물 등이 튈 우려가 있을 경우 마스크, 고글, 안면보호대(face shield)를 선택하여 사용한다.

(2) 감염을 의심하지 않더라도 에어로졸을 생성하는 처치(예 : 호흡기계 흡인, 기관 내 삽관)를 할 경우 가운, 장갑에 더하여 다음 보호구(얼굴 전체를 보호할 수 있는 안면보호대, 쉴드 마스크, 마스크와 고

글)중 하나를 착용한다.

3) 호흡기 증상이 있는 환자에게 호흡기 예절을 교육한다.

4) 환경관리

가) 병실 청소 및 소독

(1) 환자 주변 환경(침상난간, 상두대 등)과 환자가 자주 접촉하는 표면은 다른 환경 표면보다 자주 청소하고 소독한다.

(2) [7.4 환자치료영역 환경관리] 규정에 따른다.

나) 폐기물 처리 : [10.3 위험물질 관리] 규정에 따른다.

다) 식기 관리 : 식기는 일회용으로 사용하여 격리의료폐기물 전용용기에 폐기한다.

라) 세탁물 관리 : [7.3 세척・소독・멸균 및 세탁물 관리] 규정에 따른다.

5) 린넨 : 사용한 린넨은 공기, 주변 환경, 다른 환자, 취급자에게 오염되지 않도록 주의하여 다룬다.

6) 직원안전

가) 사용한 주사바늘, 날카로운 기구를 다룰 때, 사용한 기구를 세척할 때, 사용한 물품을 버릴 때 찔리지 않도록 주의한다.

나) 혈액매개 병원균에 노출된 의료종사자의 보호는 [9.4 직원안전 관리활동] 규정에 따른다.

7) 환자의 치료기구 및 물품

가) 재사용하는 물품은 세척한 후 적절한 방법으로 소독 및 멸균한다.

나) 혈액이나 체액에 오염된 물품이나 기구를 세척하는 직원은 적절한 개인보호구를 착용한다.

나. 공기주의 : 표준주의와 함께 공기주의를 적용한다.

1) 공기주의가 필요한 환자는 음압격리실 배치가 필요하지만 원내 음압격리실이 없으므로 다른 병원 이송 전까지 1인실을 사용 하도록 하고 공조기를 제어시키고 문을 항상 닫고 창문을 이용하여 수시로 환기시킨다.

2) 격리병실 제공이 불가능한 경우 대응

가) 음압 격리가 가능한 다른 병원으로 이송한다.

나) 이송이 용이하지 않은 경우, 또는 공기주의를 필요로 하는 환자들이 다수 발생하여 일반 병실로 배치를 해야 할 때에는 감염관리 의사와 상의하여 감염으로 인해 위험해질 수 있는 환자들로부터 병실을 최대한 멀리 배치해야 한다.

3) 병실 준비물품

가) 개인보호구는 병실 문 앞에 비치하고 개별 기구 및 물품은 밀폐용기에 담아 격리실 내에 비치한다.

나) 격리의료폐기물 전용용기는 병실내부에 비치한다.

4) 환경관리

가) 병실 청소 및 소독 : [7.4 환자치료영역 환경관리] 규정에 따른다.

나) 폐기물 처리 : [10.3 위험물질 관리] 규정에 따른다.

다) 식기 관리 : 식기는 일회용으로 사용하여 격리의료폐기물 전용용기에 폐기한다.

라) 세탁물 관리 : [7.3 세척・소독・멸균 및 세탁물 관리] 규정에 따른다.

5) 환자 및 보호자 대상으로 격리 관련 준수사항 교육

가) '공기주의 격리병실 생활 안내문'을 이용하여 환자 및 보호자에게 손위생과 개인보호구 착용방법, 주의사항 등 공기주의 관련 내용을 설명하고 안내문을 제공한다.

6) 환자에게 사용한 의료기기 또는 물품관리

가) 혈액, 체액, 분비물, 배설물에 오염된 환자의 치료기구는 피부나 점막, 의복 또는 다른 환자와 환경에

미생물이 전파되지 않도록 취급한다.
나) 날카로운 기구나 주사바늘은 손상성 폐기물 전용용기에 담아 버린다.
다) 오염된 재사용 기구는 사용 후 멸균 하여야 하며, 재사용 방법은 기구의 종류, 기구의 용도, 제조업체의 지침, 병원의 지침이나 규정에 따른다. 일회용은 사용 후 폐기한다.
라) 사용한 물품의 세척 시 피부나 점막이 오염되지 않도록 보호 장구를 착용한다.
마) [7.3 세척・소독・멸균 및 세탁물 관리]규정에 따른다.

7) 직원 간 정보 공유 방법 : 격리 표시
가) 병실 안과 밖에 격리표지를 부착하고 안내문을 이용하여 환자, 보호자에게 설명한다.
나) 전산에 감염환자임을 표시한다.
다) 환자인식표에 스티커를 부착하여 감염성질환자임을 표시한다.
라) 격리환자 검체에는 스티커를 부착하여 관련 직원과 공유한다.

8) 감염병 전파경로에 따른 개인보호구 종류, 착용 및 탈의 방법
가) 공기로 전파되는 병원체에 감염이 의심되거나 확진된 환자의 격리실에 들어가기 전, KF94마스크를 착용하고 제대로 착용이 되었는지 확인(Fit check)한다.
나) 호흡기 결핵이나 감염성 결핵 피부 상처가 있을 때, 결핵 확진이나 의심 환자에서 에어로졸을 생성할 수 있는 처치를 수행할 경우 KF94마스크를 착용한다.
다) 급성 호흡기 증후군, 출혈열, 전파 양식을 모르는 감염병에 대한 증상 및 징후를 보이는 환자에게 에어로졸이 형성될 수 있는 시술을 할 때에는 에어로졸 형성을 줄일 수 있는 방안을 강구하고 KF94마스크를 착용한다.

9) 환자 이송방법
가) 공기주의가 필요한 환자는 의학적으로 필요한 경우를 제외하고 병실 밖으로의 이동을 제한한다.
나) 공기주의가 필요한 환자가 격리실 밖으로 이동해야 하는 경우에는 마스크를 착용하고 호흡기 예절을 준수하도록 한다.
다) 수두, 천연두나 결핵균에 의해 피부 상처에서 배액이 나오는 환자는 상처 드레싱을 한 후 이송한다.
라) 이송 중 환자가 마스크를 쓰고 있고 피부 병변이 덮여 있으면 이송 요원은 마스크나 KF94마스크를 착용할 필요가 없다.
마) 이송에 관련한 의료종사자가 해당 감염병에 면역이 형성되어 있다면 KF94마스크를 착용하지 않아도 된다.
바) 이송 도착부서에 격리정보를 제공한다.

10) 노출 후 처치
가) 홍역, 수두 혹은 천연두 환자와 보호구 착용 없이 감수성 있는 사람이 노출된 경우 즉시 적절한 면역글로불린을 투여해야 한다.
나) 노출 72시간 안에 감수성 있는 노출된 사람에게 홍역 백신을 투여한다. 혹은 백신 부작용이 있는 사람의 경우 6일 안에 면역글로불린을 투여한다.
다) 수두에 노출된 후 120시간(5일)안에 수두 백신을 투여하거나, 백신 부작용이 있는 경우(예 : 면역저하자, 임신한 여성, 분만 5일 이내 혹은 분만 후 48시간 안에 수두가 발생한 산모에서 태어난 아이) 96시간 이내 면역글로불린을 투여한다.
라) 천연두에 노출된 감수성 있는 사람에게는 노출된 지 4일 이내 천연두 백신을 투여한다.

11) 관련 직원 교육
가) 교육내용 : 전파경로에 따른 격리 원칙(격리병실 제공이 불가능한 경우 대응포함), 개인보호구 종류 및

착용 · 탈의 순서, 환자, 보호자에게 시행해야 할 격리관련 교육 내용, 의료기기 및 물품 관리 방법, 환경관리 원칙(병실 청소 및 소독, 폐기물 처리, 식기 관리, 세탁물 관리 등), 방문객 관리

나) 교육방법 : 연1회 온라인 교육 또는 필요시 부서별 개별교육 한다.

12) 방문객 관리

가) 환자와 방문객, 가족과 간병인에게 전파를 예방하기 위해 격리기관과 주의사항, 예방 방법에 대해 안내한다.

나) 간병인은 개인보호구 착용의 적응증과 방법에 대해 교육한다.

다) 활동성 결핵 환자의 경우 방문객의 출입을 제한한다.

라) 수두나 홍역 환자의 경우 방문객은 병실에 들어가기 전에 간호사에게 이야기하도록 하고 항체가 없다면 꼭 필요한 경우를 제외하고는 방문을 제한하고 방문이 필요한 경우에는 KF94마스크를 착용한다.

다. 비말주의 : 표준주의와 함께 비말주의를 적용한다.

1) 격리병실 배치

가) 가능한 한 1인실에 배치한다.

나) 1인실 수가 제한적이라면 과도한 기침과 객담이 있는 환자, 활동량이 많을 것으로 예상되는 환자는 1인실을 우선적으로 배치한다.

2) 격리병실 제공이 불가능한 경우 대응

가) 동일한 병원체에 감염되었고 다른 감염이 없는 환자끼리 동일한 병실에 코호트 한다.

나) 코호트 격리를 한 경우에는 병상 간 이격 거리는 1m이상 유지한다.

다) 접촉의 기회를 줄이기 위해 가능한 한 침대 사이에 물리적 칸막이(커튼)을 설치한다.

라) 코호트도 어려운 상황에서 비말주의가 필요한 환자와 동일한 병원체에 감염되지 않은 다른 환자가 공동으로 병실을 사용해야 하는 경우에는 감염의 전파로 인해 예후가 좋지 않을 수 있는 환자(예 : 면역저하 환자 등)와 같이 두어서는 안 된다.

마) 코호트가 어려운 상황에서 비말주의 환자와 같은 병실의 환자를 접촉하는 경우, 동일한 병실에 입원한 환자와 공간적으로 1.5m이상 확보하고, 직접접촉의 기회를 최소화 하기 위해 물리적 차단막(커튼)을 설치하며 비말주의 유무에 상관없이 환자마다 개인보호구를 교체하고 손위생을 수행한 후 접촉한다.

3) 병실 준비물품

가) 개인보호구는 병실 문 앞에 비치하고 개별 기구 및 물품을 밀폐용기에 담아 격리 공간 내에 비치한다.

나) 격리의료폐기물 전용용기는 병실 안에 비치한다.

4) 환경관리

가) 병실 청소 및 소독 : [7.4 환자치료영역 환경관리] 규정에 따른다.

나) 폐기물 처리 : [10.3 위험물질 관리] 규정에 따른다.

다) 식기 관리 : 식기는 일회용으로 사용하여 격리의료폐기물 전용용기에 폐기한다.

라) 세탁물 관리 : [7.3 세척 · 소독 · 멸균 및 세탁물 관리]규정에 따른다.

5) 환자 및 보호자 대상으로 격리 관련 준수사항 교육

가) '비말주의 격리병실 생활 안내문'을 이용하여 환자 및 보호자에게 손위생과 개인보호구 착용방법, 주의사항 등 비말주의 관련 내용을 설명하고 안내문을 제공한다.

6) 환자에게 사용한 의료기기 또는 물품 관리 : [7.3 세척 · 소독 · 멸균 및 세탁물 관리]규정에 따른다.

7) 직원 간 정보 공유 방법 : 격리 표시

가) 병실 안과 밖에 격리표지를 부착하고 코호트를 구성하는 경우 침상에 격리표시를 부착한다. 안내문을 이용하여 환자, 보호자에게 설명한다.

나) 전산에 감염환자임을 표시한다.
다) 환자인식표에 스티커를 부착하여 감염성질환자임을 표시한다.
라) 격리환자 검체에는 스티커를 부착하여 관련 직원과 공유한다.
8) 감염병 전파경로에 따른 개인보호구 종류, 착용 및 탈의 방법
가) 비말주의가 필요한 환자의 병실에 들어갈 때에는 수술용 마스크를 착용한다.
9) 환자 이송방법
가) 가급적 병실 밖으로의 이동을 제한한다.
나) 비말주의가 필요한 환자가 격리실 밖으로 이동해야 하는 경우에는 마스크를 착용하고 호흡기 예절을 준수하도록 한다.
다) 병실 밖을 나가기 전에 손위생을 수행한다.
라) 환자가 수술용 마스크를 착용하고 있다면 비말주의 환자를 이송하는 사람은 수술용 마스크를 반드시 착용할 필요는 없다.
마) 이송 도착부서에 격리정보를 제공한다.
10) 관련 직원 교육
가) 교육내용 : 전파경로에 따른 격리 원칙(격리병실 제공이 불가능한 경우 대응포함), 개인보호구 종류 및 착용・탈의 순서, 환자, 보호자에게 시행해야 할 격리관련 교육 내용, 의료기기 및 물품 관리 방법, 환경관리 원칙(병실 청소 및 소독, 폐기물 처리, 식기 관리, 세탁물 관리 등), 방문객 관리
나) 교육방법 : 연1회 온라인 교육 또는 필요시 부서별 개별교육 한다.
11) 방문객 관리
가) 가족과 방문객에게 현재 적용 중인 주의와 격리기간, 손위생과 같은 예방법에 대해 교육한다.
나) 환자의 치료와 간호에 관여하는 보호자에게는 개인보호구 착용의 적응증과 올바른 사용 방법에 대해 교육한다.
다) 방문객은 필요한 경우에 한하여 최소화하며 한 환자만 방문하도록 제한한다.
라) 풍진과 유행성하선염이 있는 환자의 방문객이 면역이 형성되어 있다면 수술용 마스크를 착용할 필요가 없다. 만약 면역이 없다면 꼭 필요한 경우를 제외하고 방문하지 말아야 한다. 만약 반드시 방문을 해야 한다면 수술용 마스크를 착용한다.
마) 지역사회나 병원에서 호흡기 감염이 유행하는 경우에는 방문객 제한을 고려한다.

라. 접촉주의 : 표준주의와 접촉주의를 적용한다.

1) 격리병실 배치
가) 가능하면 1인실에 배치한다.
나) 오염이 촉진될 수 있는 환자(예 : 삼출물이 계속 배액되어 주변을 오염시킬 경우, 실변)의 경우 우선적으로 1인실에 배치한다.
2) 격리병실 제공이 불가능한 경우 대응
가) 동일한 병원체에 감염되었고 다른 감염이 없는 환자끼리 동일한 병실에 코호트 한다.
나) 코호트 격리에서 접촉주의 환자는 감염전파로 인하여 예후가 좋지 않을 수 있는 환자(예 : 면역저하 환자, 개방성 창상이 있는 환자, 혹은 오랜 기간 입원이 필요한 환자)와 같은 병실에 배치하지 않는다.
다) 코호트 격리도 어려운 경우, 환자 병상 간 이격거리는 1m 이상 유지한다.
라) 접촉의 기회를 줄이기 위해 가급적이면 물리적 차단막(커튼)을 설치한다.
3) 병실 준비물품
가) 개인보호구는 병실 문 앞에 비치하고 개별 기구 및 물품을 밀폐용기에 담아 격리실 내에 비치한다.

나) 격리의료폐기물 전용용기는 병실 안에 비치한다.

4) 환경관리

가) 병실 청소 및 소독

(1) 접촉주의 병실은 다른 병실보다 더 자주 청소하고 소독해야 하며, 특히 환자가 자주 만지는 표면과 물건은 철저히 청소하고 소독한다.

(2) [7.4 환자치료영역 환경관리] 규정에 따른다.

나) 폐기물 처리 : [10.3 위험물질 관리] 규정에 따른다.

다) 식기 관리 : 식기는 일회용으로 사용하여 격리의료폐기물 전용용기에 폐기한다.

라) 세탁물 관리 : [7.3 세척・소독・멸균 및 세탁물 관리]규정에 따른다.

5) 환자 및 보호자 대상으로 격리 관련 준수사항 교육

가) '접촉주의 격리병실 생활 안내문'을 이용하여 환자 및 보호자에게 손위생과 개인보호구 착용방법, 주의사항 등 비말주의 관련 내용을 설명하고 안내문을 제공한다.

6) 환자에게 사용한 의료기기 또는 물품 관리 : [7.3 세척・소독・멸균 및 세탁물 관리]규정에 따른다.

7) 직원 간 정보 공유 방법 : 격리 표시

가) 병실 안과 밖에 격리표지를 부착하고 코호트를 구성하는 경우 침상에 격리표시를 부착한다. 안내문을 이용하여 환자, 보호자에게 설명한다.

나) 전산에 감염환자임을 표시한다.

다) 환자인식표에 스티커를 부착하여 감염성질환자임을 표시한다.

라) 격리환자 검체에는 스티커를 부착하여 관련 직원과 공유한다.

8) 감염병 전파경로에 따른 개인보호구 종류, 착용 및 탈의 방법

가) 접촉주의가 필요한 환자를 직접 접촉하거나 환자 주변의 물건을 만져야 할 때에는 손위생 수행 후 장갑을 착용하고 옷이 오염될 것으로 예상될 때에는 가운을 착용한다.

나) 접촉주의에 필요한 개인보호구는 병실 입구에서 착용한다.

다) 병실을 나오기 전 장갑과 가운을 벗어 의료폐기물 전용용기에 버리고 손위생을 수행한다.

라) 가운을 벗은 후에는 옷이나 피부가 주변 환경에 오염되지 않도록 주의한다.

9) 환자 이송방법

가) 가능하면 환자의 이동을 제한한다.

나) 접촉주의가 필요한 환자를 이송하는 경우 이송 요원과 도착지의 의료종사자에게 주의사항을 알린다.

다) 환자의 이동이 불가피하다면 감염되거나 집락 된 환자의 부위를 잘 덮어야 한다.

라) 환자 이송자는 접촉주의 환자를 이동시키기 전 오염된 개인보호구를 제거하고 손위생을 한다.

마) 이송을 담당하는 요원과 도착지의 의료종사자는 개인보호구를 착용한다.

바) 이송 도착지에 있는 의료종사자는 주의사항을 미리 파악하여 환자가 병실 밖에서 대기하는 시간을 최소화한다.

사) 접촉주의 환자는 병실 밖으로 나가기 전에 손위생을 시행한다.

10) 관련 직원 교육

가) 교육내용 : 전파경로에 따른 격리 원칙(격리병실 제공이 불가능한 경우 대응포함), 개인보호구 종류 및 착용・탈의 순서, 환자, 보호자에게 시행해야 할 격리관련 교육 내용, 의료기기 및 물품 관리 방법, 환경관리 원칙(병실 청소 및 소독, 폐기물 처리, 식기 관리, 세탁물 관리 등), 방문객 관리

나) 교육방법 : 연1회 온라인 교육 또는 필요시 부서별 개별교육 한다.

11) 방문객 관리

가) 가족과 방문객에게 현재 적용 중인 주의와 격리기간, 손위생과 같은 전파 예방법에 대해 교육한다.

나) 방문객은 필요한 경우에 한하여 최소화하며 한 환자만 방문하도록 제한한다.

마. 혈액매개주의 : 표준주의와 동일하게 적용한다

[감염 경로별 감염관리의 기본 주의사항]

구분	표준주의 (Standard precaution)	공기주의 (Airbone precaution)	비말주의 (Droplet precaution)	접촉주의 (Contact precaution)
격리실	개인위생을 적절히 유지	감염기간 동안 반드시 격리 필요	표준주의에 준함	표준주의에 준함
마스크 착용	마스크 : 혈액/체액 등이 튈 가능성이 있는 경우	KF94마스크 : 출입하는 모든 사람은 반드시 착용	마스크 : 환자와 1m 이내에 있을 경우, 혈액/v체액 등이 튈 가능성이 있는 경우	마스크 : 혈액/체액 등이 튈 가능성이 있는 경우
보안경 착용	혈액이나 체액 등이 눈에 튈 가능성이 있는 경우	표준주의에 준함	표준주의에 준함	표준주의에 준함
가운 착용	혈액이나 체액 등이 의복에 튈 가능성이 있는 경우	표준주의에 준함	표준주의에 준함	병실 입실 전 착용, 나오기 전 제거
장갑 착용	혈액이나 체액, 기타 오염된 물품을 만질 경우 손상된 피부나 점막을 만질 경우	표준주의에 준함	표준주의에 준함	병실 입실 전 착용, 나오기 전 제거

▣ 부록(Appendix)

1. 개인보호구 종류
2. 전파경로에 따른 격리방법
3-1. 개인보호구 착의법
3-2. 개인보호구 탈의법
4. 격리표시
5-1. 공기주의 격리병실 생활 안내문
5-2. 비말주의 격리병실 생활 안내문
5-3. 접촉주의 격리병실 생활 안내문
6. 격리실 환자관리 체크리스트

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

부록1. 개인보호구 종류

1. 마스크

가. 마스크를 사용하는 경우

1) 호흡기계나 비말 전파가 가능한 환자의 병실을 들어가기 전
2) 면역저하 환자와 접촉하기 전

나. 마스크 사용 원칙

1) 비말 전파가 가능한 환자와 1m 내에서 접촉할 경우, 면역저하 환자와 접촉할 경우 마스크를 착용한다.
2) 활동성 결핵환자나 의심 환자를 다룰 때는 KF94마스크의 착용을 권한다.
3) 입과 코를 충분히 가릴 수 있어야 한다. KF94마스크의 경우 착용 한 후에는 마스클 움켜쥐고 '후' 공기를 불어 새는 곳이 없는지 Fit check를 실시한다.
4) 1회 사용을 원칙으로 하며 한 번 제거하면 재사용하지 않는다.
5) 목에 걸치거나 주머니에 넣고 다니지 않는다.
6) 마스크, 가운, 장갑을 착용한 상태에서 벗는 순서는 장갑, 가운을 벗고 손위생을 한 후 마스크를 제거한다.

다. 마스크 착용 방법

1) 손위생을 시행한다.
2) 마스크의 위쪽 가장자리를 콧마루에 놓고 윗끈은 귀의 윗부분을 따라 머리 뒤에서 묶는다. 안경을 쓸 때는 위쪽 가장자리가 안경 안쪽으로 놓이도록 한다.
3) 아래쪽 가장자리는 턱 아래에 고정시키고 아래끈은 목덜미에서 묶어 마스크와 코와 입을 완전히 덮도록 한다.
4) 만일 마스크에 금속선이 들어있으면 콧마루에 맞추어 눌러준다.

라. 마스크 제거 방법

1) 장갑을 끼고 있다면 장갑을 벗고 손위생 후 마스크를 제거한다. 이는 미생물이 머리에 닿지 않도록 하기 위해서이다.
2) 끈에만 손을 대면서 마스크를 벗는다.
3) 벗은 마스크는 의료폐기물 전용용기에 버린다.
4) 손위생을 시행한다.



승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

[외과용 마스크 착용 및 제거 방법]



[KF94마스크 착용 방법]

2. 장갑

가. 장갑을 착용해야 하는 경우

1) 환자의 혈액이나 체액, 상처의 분비물, 배설물과 접촉하거나 점막 그리고 손상된 피부와 접촉할 때 손의 오염을 방지하기 위하여 사용한다.

2) 환자의 치료나 침습적 과정에서 의료진의 손에 상주하는 균이 환자에게 전파될 가능성을 줄인다.

나. 장갑 사용 원칙

1) 장갑 착용 전후에 손위생을 한다. 장갑을 착용하는 것으로 손위생을 대신할 수 없는데 그 이유는 장갑에는 육안으로 보이지 않는 결함이 있을 수 있고 사용하는 동안 장갑이 찢어지거나 벗는 과정에서 오염될 가능성이 있기 때문이다.

2) 장갑은 1회 사용을 원칙으로 하며, 같은 환자에게 사용하더라도 사용 부위가 달라지면 교환하도록 한다.

3) 격리실에서의 장갑은 방을 나가기 전에 벗고 다인용 병실에서는 다른 환자로 옮기기 이전에 접촉한 환자 주변에서 벗는다.

4) 찢어진 장갑은 즉시 교환한다.

5) 장갑이 찢어지는 것을 방지하기 위해 손톱은 짧고 날카롭지 않게 유지한다.

6) 장갑 착용에 방해가 되는 장신구와 인공손톱은 피한다.

7) 마스크, 장갑, 가운을 모두 사용할 때에는 마스크, 가운, 장갑의 순으로 착용한다.

8) 장갑은 손에 맞는 것을 사용한다.

9) 손위생 후 완전히 손을 건조시키고 장갑을 착용한다.

다. 장갑의 종류와 선택

1) 멸균장갑

가) 외과적 시술, 침습적 처치 등을 위한 무균술에 사용한다.

나) TPN 및 항암제 준비 시

2) 청결장갑 : 멸균 부위가 아닌 체액, 혈액 등 인체의 분비물과 접촉하는 경우에 사용한다.

라. 멸균장갑 착용 방법

1) 손위생을 시행한다. 마스크, 장갑, 가운을 모두 사용할 경우 마스크, 손위생, 가운 순으로 착용한 후 장갑을 착용한다.

2) 왼손으로 오른손 장갑 손목의 접힌 부분 즉, 커프를 잡아 올리면서 오른손을 장갑 안으로 집어넣는다.

3) 장갑을 낀 오른손으로 왼쪽 장갑의 커프 밑에 네 손가락을 넣고 왼손을 장갑 안으로 집어넣는다.

4) 가운을 입었을 때는 소매 끝을 덮도록 장갑을 올린다. 가운을 입지 않았다면 손목 위까지 잡아당긴다.

마. 장갑 제거 방법

1) 한 손으로 다른 손 장갑의 손목 앞부분을 잡고 안쪽이 바깥쪽으로 뒤집혀지도록 벗는다. 오염된 장갑의 바깥쪽이 손목이나 손의 피부에 닿지 않도록 한다.

2) 장갑 낀 손은 먼저 벗은 뒤집어진 장갑을 잡고 있다.

3) 벗은 쪽 손가락을 다른 손 장갑 안쪽에 넣는다. 벗은 손에 오염된 장갑의 바깥쪽이 닿지 않도록 한다.

4) 손가락을 바깥쪽으로 향해 당기면서 뒤집어 벗는다. 이때 먼저 벗은 장갑이 두 번째 장갑 안으로 들어가도록 한다.

5) 벗은 손이 깨끗한 장갑의 안쪽만 닿도록 장갑을 제거하고 완전히 뒤집어서 의료폐기물 전용용기에 넣는다.

6) 손위생을 시행한다.



[멸균장갑 착용, 제거 방법]

3. 가운

가. 가운을 적용해야 하는 경우

1) 감염성질환자와 접촉 시 의료진의 유니폼이 감염성 물질에 오염될 우려가 있을 경우

2) 처치나 환자 진료 시 혈액, 체액, 분비물 및 배설물과 접촉이 예상될 경우

3) 병문안객이 환자 병실 출입 시 오염된 의복으로부터 미생물, 오물 오염 될 우려가 있을 경우

나. 가운 착용의 원칙

1) 가운이 필요한 지역을 떠날 때는 떠나기 전에 벗는다.

2) 여러 환자가 함께 있는 병실에서 가운을 입고 처치한 후 가운을 입은 채로 다른 환자에게 가면 안

된다.

3) 가운을 입을 때는 가운의 앞면 상반신 쪽을 무균지역으로 간주하고 이곳을 접촉하지 않는다.

4) 가운을 벗을 때는 앞면을 오염된 것으로 간주하고 접촉하지 않도록 조심하여 벗는다. 가운 벗은 후 손위생을 시행한다.

5) 한 번 사용한 가운은 다시 입지 않는다.

6) 오염된 가운은 다른 환자나 환경에 미생물 전파를 막기 위해, 가능한 한 빨리 벗고 손위생 한다.

다. 가운 착용 방법

1) 가운 입기

가) 손위생을 시행한다.

나) 가운을 집어 바닥이나 오염된 장소에 닿지 않도록 편다.

다) 가운 소매 속으로 손을 집어넣어 당기면서 팔을 끼운다.

라) 목의 끈을 묶는다.

마) 뒷자락이 잘 여며지도록 허리끈을 뒤에서 묶는다.

바) 필요하면 멸균장갑을 낀다.

2) 가운 벗기

가) 장갑은 벗어서 의료폐기물 전용용기에 넣는다.

나) 가운의 허리띠를 풀어 옆으로 늘어뜨린다.

다) 목끈을 풀고 가운이 어깨에 걸치도록 한 후 가능한 한 바깥부분이 닿지 않도록 내린다.

라) 가운 안쪽에서 손을 움직여 소매를 내린다.

마) 안쪽에서 어깨솔기를 두 손으로 잡고 가운을 붙든 후 손을 모은다. 깨끗한 안쪽이 바깥으로 나오도록 한 쪽 어깨를 위로해서 뒤집는다.

바) 가운을 말아서 의료폐기물 전용용기에 넣는다.

사) 감염성 물질에 손이 오염되었으면 손위생을 시행한다.

아) 마스크를 벗어서 의료폐기물 전용용기에 넣는다.

자) 손위생을 시행한다.



[가운 착용 및 제거 방법]

4. 보호안경, 안면보호구

가. 보호안경, 안면보호구를 사용하는 경우

1) 환자의 치료나 간호 행위 도중에 혈액이나 체액, 오염물이 튈 가능성이 있는 경우 눈과 코와 입을

보호하기 위해 착용한다.

2) 보호안경과 안면보호구는 단독 또는 병용해서 사용한다.

3) 새로운 환자를 볼 때마다 보호안경과 안면보호구를 세척하고 적절히 소독한다.

나. 보호안경, 안면보호구를 적용하는 방법 : 얼굴에 쓰고 조정한다.

다. 보호안경, 안면보호구를 제거하는 방법

1) 안경 혹은 안면보호구의 바깥쪽이 오염된 것으로 간주한다.

2) 깨끗한 머리밴드나 귀걸이 부분과 접촉하여 제거하고 일회용일 경우 의료폐기물 전용용기에 넣고 재사용일 경우 세척하고 소독한다.

3) 오염된 보호안경이나 안면보호구는 제조회사의 지침에 따른다.

5. 앞치마

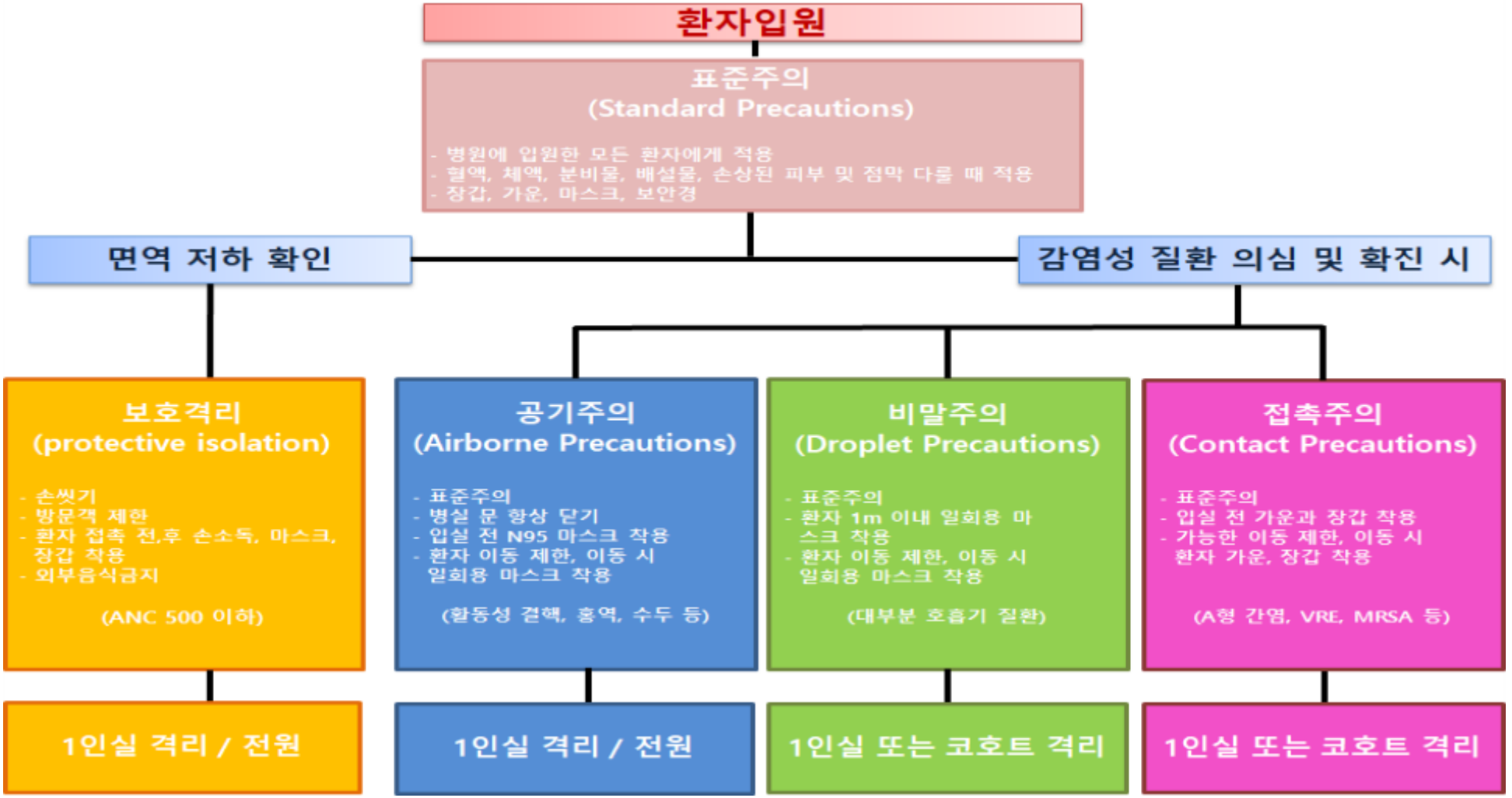
가. 의복의 오염을 최소화하기 위하여 착용한다.

나. 오염된 기구를 취급하거나 세척할 때 방수 앞치마를 사용한다.

6. 개인보호구 사용 순서

손위생 -> 가운 -> 마스크 -> 보호안경/안면보호구 -> 장갑 착용 -> 격리환자 접촉 -> 장갑 제거 -> 가운 제거 -> 손위생 -> 보호안경/안면보호구 제거 -> 손위생 -> 마스크 제거 -> 손위생

부록2. 전파경로에 따른 격리방법



부록 3-1) 개인보호구 착의법



부록 3-2) 개인보호구 탈의법



부록4. 격리표시

부록5-1. 공기주의 격리병실 생활 안내문

공기격리 병실생활안내

♣ 보호자와 방문객은 가능한 면회를 제한하도록 하며, 병실에 머무는 보호자는 1인으로 제한하도록 합니다. 다음의 내용들을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 병실 문은 항상 닫혀 있어야 하고 바깥 외부 창문을 열어 환기를 시킵니다.
2. 보호자와 방문객의 수는 최소화 하고 병실에 들어갈 때에는 반드시 KF94 마스크를 착용하여야 합니다.
3. 소아와 면역저하 환자의 면회는 금합니다.
4. 환자는 기침이나 객담 배출 시 꼭 휴지를 사용하도록 하며, 사용한 휴지는 감염성폐기물 통에 버립니다.
5. 기침이나 객담을 뱉은 후에는 물과 비누로 손을 씻거나 손 소독제를 바르는 등 손 위생을 실시합니다.
6. 환자 이동은 가능한 제한하며, 부득이하게 이동 시 환자에게 반드시 마스크를 착용시킵니다.

♣ 환자분의 빠른 쾌유를 바랍니다 ♣

부록 5-2) 비말주의 격리병실 생활 안내문

비말격리 병실생활안내

♣ 보호자와 방문객은 가능한 면회를 제한하도록 하며, 병실에 머무는 보호자는 1인으로 제한하도록 합니다. 다음의 내용들을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 보호자나 방문객은 병실을 출입할 때 손 위생을 시행합니다.
2. 환자와 접촉 전에는 손 위생을 하고 환자와의 거리가 1m 이내일 경우에는 외과용 마스크를 착용합니다.
3. 소아와 면역저하 환자의 면회는 금합니다.
4. 환자는 기침이나 객담 배출 시 꼭 휴지를 사용하도록 하며, 사용한 휴지는 감염성폐기물 통에 버립니다.
5. 기침이나 객담을 뱉은 후에는 물과 비누로 손을 씻거나 손 소독제를 바르는 등 손 위생을 실시합니다.
6. 환자 이동은 가능한 제한하며, 부득이하게 이동 시 환자에게 반드시 마스크를 착용시킵니다.

♣ 환자분의 빠른 쾌유를 바랍니다 ♣

부록 5-3) 접촉주의 격리병실 생활 안내문

접촉격리 병실생활안내

♣ 보호자와 방문객은 가능한 면회를 제한하도록 하며, 병실에 머무는 보호자는 1인으로 제한하도록 합니다. 다음의 내용들을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 보호자와 방문객은 병실 출입 전, 후 물과 비누로 손을 씻거나 손 소독제를 바르는 등 손 위생을 시행합니다.
2. 병실에서 환자와 밀접한 접촉을 할 경우에는 일회용 비닐장갑과 가운을 착용하며, 특히 환자의 소변이나 대변 등의 분비물을 접촉 할 경우에는 반드시 장갑을 착용합니다.
3. 장갑은 사용 후 즉시 벗어 감염성 폐기물통에 넣고 손위생을 시행합니다
4. 보호자가 밖으로 나올 때는 일회용 장갑과 가운을 병실 안에서 벗어 감염성 폐기물 통에 넣고 손위생을 시행한 후 병실 밖으로 나옵니다.
5. 환자가 사용한 세탁물은 방안에 있는 오염 린넨통에 넣도록하며 그냥 밖으로 나오지 않도록 합니다.
6. 다른 환자나 다른 환자의 물품은 만지지 않도록 합니다.
7. 환자 이동은 가능한 제한하며, 부득이하게 이동 시 환자의 환의를 모두 갈아입히고 손 위생을 하도록 한 후 이동합니다.

♣ 환자분의 빠른 쾌유를 바랍니다 ♣

네이처 요양병원
NATURE HOSPITAL

역격리 병실생활안내

보호자와 방문객은 가능하면 면회를 제한하도록 하며, 병실에 머무는 보호자는 1인으로 제한 합니다.

♣ 다음의 내용들을 반드시 지켜주시기 바랍니다. ♣

1. 병실 출입 전 반드시 물과 비누로 손을 씻거나 손 소독제를 바르는 등 손 위생을 실시합니다.
2. 병실 문은 항상 닫아 놓습니다.
3. 환자는 가능한 병실 바깥으로 나가지 않도록 하며, 나갈 때는 수술용 마스크를 착용하고 나가도록 합니다.
4. 면회객이나 보호자는 방안에서 수술용 마스크를 착용하고 있도록 합니다.
5. 조리된 음식을 섭취하고 미생물 및 질병전파의 우려가 있으므로 외부의 음식과 꽃, 식물은 반입을 제한하여 주시기 바랍니다.
6. 면회 금지를 원칙으로 하며, 특히 감염성질환을 가진 방문객은 출입을 금합니다.
7. 환자 이동은 가능한 제한하며, 부득이하게 이동 시 환자에게 외과용 마스크를 착용시킵니다.
8. 특히 공사 장소 인근을 방문할 경우에는 KF94 마스크를 착용시킵니다.

♣ 환자분의 빠른 쾌유를 바랍니다 ♣

부록6. 격리실 체크리스트

(　　)월 (　　)병동 (　　)격리실 체크리스트

격리날짜:　　년　　월　　일

종 류	항목/일자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
개인 물품	체온계																															
	혈압계																															
	청진기																															
	Torniquet																															
	IV pole																															
	기타 (Wheel chair 등)																															
손소독제	알코올 손소독제																															
손위생	환자 접촉 전																															
	환자 접촉 후																															
	병실 나오기 전																															
	장갑 벗은 후																															
장갑 사용	환자 접촉 전																															
	분비물 만지기 전																															
	침습적 치료 전																															
보호구	가운(설사, 장루, 상처, 주위환경과 접촉 등)																															
	마스크(공기주의, 비말주의)																															
	안면보호구(분비물이 튀거나, 혈액매개성 질환 등)																															
환경 관리	손상성폐기물 전용용기 비치																															
	격리의료폐기물 전용용기 비치																															
	환의 및 린넨 분리수거																															
점검자																																
범례 적합:O, 부적합:X		※ 조치가 필요한 사항 : 부서장 확인 (인)																														

부록7. 법정 감염병 분류 및 종류

법정 감염병 분류 및 종류

구분	제1급감염병(17종)	제2급감염병(20종)	제3급감염병(26종)	제4급감염병(23종)
유형	생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단발생우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고하고 음압격리가 필요한 감염병	전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행시 24시간 이내에 신고하고 격리가 필요한 감염병	발생 또는 유행시 24시간 이내에 신고하고 발생을 계속 감시할 필요가 있는 감염병	제1급-제3급 감염병 외에 유행여부를 조사하기 위해 표본감시 활동등이 필요한 감염병
종류	가. 에볼라바이러스병 나. 마버그열 다. 라싸열 라. 크리미안콩고출혈열 마. 남아메리카출혈열 바. 리프트밸리열 사. 두창 아. 페스트 자. 탄저 차. 보툴리눔독소증 카. 야토병 타. 신종감염병 증후군 파.중증급성호흡기증후군(SARS) 하. 중동호흡기증후군 거. 동물인플루엔자 인체감염증 너. 신종인플루엔자 더. 디프테리아	가. 결핵 나. 수두 다. 홍역 라. 콜레라 마. 장티푸스 바. 파라티푸스 사. 세균성 이질 아. 장출혈성대장균감염증 자. A형 간염 차. 백일해 카. 유행성이하선염 타. 풍진 파. 폴리오 하. 수막구균 감염증 거. B형 헤모필루스 인플루엔자 너. 폐렴구균 감염증 더. 한센병 러. 성홍열 머.반코마이신내성황색 포도알균(VRSA)감염증 버. 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 코로나19 바이러스 감염증	가. 파상풍 나. B형 간염 다. 일본 뇌염 라. C형 간염 마. 말라리아 바. 레지오넬라증 사. 비브리오패혈증 아. 발진티푸스 자. 발진열 차. 쯔쯔가무시증 카. 렙토스피라증 타. 브루셀라증 파. 공수병 하. 신증후군출혈열 거.후천성면역결핍증(AIDS) 너. 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 더. 황열 러. 뎅기열 머. 큐열 버. 웨스트나일열 서. 라임병 어. 진드기매개뇌염 저. 유비저 처. 치쿤구니야열 커. 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 터. 지카바이러스감염증	가. 인플루엔자 나. 매독 다. 회충증 라. 편충증 마. 요충증 바. 간흡충증 사. 폐흡충증 아. 장흡충증 자. 수족구병 차. 임질 카. 클라미디아감염증 타. 연성하감 파. 성기단순포진 하. 첨규콘딜롬 거.반코마이신내성장열균(VRE)감염증 너. 메티실린내성황색포도알균(MRSA)감염증 더. 다제내성녹농균(MRPA)감염증 러. 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB)감염증 머. 장관감염증 버. 급성호흡기감염증 서. 해외유입기생충감염증 어. 엔테로바이러스감염증 저. 사람유두바이러스 감염증
감시방법	전수	전수	전수	표본
신고	즉시	24시간이내	24시간이내	7일이내
보고	즉시	24시간이내	24시간이내	7일이내

부록2. 전파경로에 따른 주의지침

[전파경로에 따른 주의지침]

<table>
<tr><th></th><th>표준주의</th><th>공기주의</th><th>비말주의</th><th>접촉주의</th></tr>
<tr><td>해당질병</td><td>모든 환자에게 적용</td><td>결핵, 수두,
홍역</td><td>인플루엔자,
백일해 등</td><td>VRE, MRSA,
C.difficile
Rota Virus등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1인실</td><td rowspan="2">개인위생을 적절히
지키지 못할 때 필요</td><td>가급적
병실방문은 항상
닫아둔다.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1인실 또는 코호트 격리</td></tr>
<tr><td>손위생</td><td>환자접촉 전
환자접촉 후
청결/무균처치 전
혈액/체액과 접촉한 후
환자의 주변 환경과
접촉한 후
투약시
수술/시술 전.후</td><td colspan="3">표준주의와 동일</td></tr>
<tr><td>장갑</td><td>침습적/무균술 시행시
혈액,체액, 분비물 등
미생물과의 접촉이 예상
되는 경우</td><td colspan="2">표준주의와 동일</td><td>표준주의
+환자접촉 전
항시 착용</td></tr>
<tr><td>가운,
비닐앞치마</td><td>혈액, 체액, 분비물 등이 의료진의 피부, 의복을 전염시킬 우려가 있을 때</td><td colspan="2">표준주의와 동일</td><td>표준주의
+환자접촉 전
항시 착용</td></tr>
<tr><td>마스크</td><td>혈액, 체액, 분비물 등이 튈 것이 예상될 때</td><td>KF94 마스크</td><td>+환자접촉 전
항시 착용</td><td>표준주의와동일</td></tr>
<tr><td>보안경</td><td>혈액, 체액, 분비물 등이 얼굴에 튈 것이 예상될 때</td><td colspan="3">표준주의와 동일</td></tr>
<tr><td>환자이동</td><td></td><td colspan="2">가능한 제한
이동시 환자에게 외과용 마스크
착용</td><td>가능한 제한</td></tr>
</table>

부록3. 감염성 질환 발생 보고서

감염성 질환 발생 보고서

결제	담당자	부서장	병원장

성명 :	등록번호 :	성별/나이 :
병실/진료부 :	진 단 명 :	
입원일 :	발생일시 : 년 월 일 시	

감염균주			
의식상태	☐명료(alert) ☐졸음(drowsy) ☐혼돈(stupor) ☐반혼수(semi-coma) ☐혼수(coma)		
활동 및 기능	☐독립적 ☐부분도움(보조기구 사용) ☐항상 도움필요 ☐침상에만 유지		
보조기 사용	☐무 ☐유(종류:)		
환자관련 요인 (모두 선택)	☐어지러움 ☐흥분 ☐전신쇠약 ☐마비 ☐시력장애 ☐체위성저혈압 ☐평형장애 ☐보행장애 ☐수면장애 ☐낙상경력(1년 이내) ☐기타( )		
투여약물			
검체부위			
경과			
진행사항			
보고일시		보고자	

부록4. 감염관리 지침- VRE, 옴

VRE 감염관리 지침(접촉주의)

항목	세부 관리지침
1. 병실배치	① 1인실 격리실에 격리 ② 코호트 격리
2. 병실 출입자 준수사항	① 환자 접촉 전과 환자 침상주변과 접촉 시 일회용 장갑과 일회용 가운을 착용한다. ② 환자와 접촉 후 장갑과 가운을 병실 내에서 벗어 감염성 폐기물 통에 폐기한다. ③ 손 위생→가운착용→장갑착용→병실에 들어가서 환자 처치 →장갑제거→가운제거→손 위생→병실에서 나옴→손 위생
3. 환자이송	① 가능한 처치를 격리실 안에서 시행하여 환자의 이동을 최소화 한다. ② 환자 이동 시에는 해당부서에 미리 정보를 주어 환경오염을 최소화한다.
4. 기구관리 및 병실소독	① 청진기, 혈압계, 체온계 등은 개별적으로 사용하며, 다른 환자에게 사용하기 전에 반드시 소독을 한 후에 사용한다. ② 환자가 사용한 린넨과 환의는 분리수거하여 오염세탁물통에넣는다. ③ 주변환경은 매일 1회 이상 소독제로 닦는다. ④ 환자 퇴원 후 오염가능성이 높은 침대, 상두대, 화장실 손잡이, 냉장고 손잡이 등을 소독제로 소독한다. 다른 병실 청소 후 마지막으로 청소한다.
5. 격리기간	직장도말에서 일주일 간격으로 시행한 배양검사가 3회 연속 음성인 경우

옴 감염관리 지침

항목	세부 관리지침
1. 병실배치	① 1인실 격리실에 격리 ② 환자상태에 따라 격리기간을 평가한다.
2. 병실 출입자 준수사항	① 환자 접촉 전, 환자 침상 주변과 접촉 시 일회용 장갑과 일회용 가운을 착용한다. ② 환자와 접촉한 후 장갑은 벗고 손 위생을 시행한다.
3. 환자이송	① 가능한 처치를 격리실 안에서 시행하여 환자의 이동을 최소화 한다.
4. 린넨 및 환경관리	① 린넨류(침대시트와 환의)는 치료제를 바르는 동안 같은 것을 사용하며, 린넨 취급 시 반드시 장갑을 착용한다. ② 사용한 린넨은 비닐봉투에 3일간 밀봉한 후 오염세탁물로 분리 배출한다. ③ 청진기, 혈압계, 체온계 등은 개별적으로 사용하며, 사용하고 남은 치료약은 모두 폐기한다.
5. 노출된 직원관리	① 노출이 의심되는 직원은 감염증상(피부발진, 소양감 등)이 있는지 매일 확인한다. ② 옴 감염전파가 확인 될 경우 직접적인 접촉자에 대한 예방적 치료를 고려 할 수 있다. ③ 감염된 직원은 치료 시작 후 24시간이 지날 때까지 근무를 제한한다.

부록4. 격리 시작 시 격리절차/유행감염병 의심환자 내원 시 업무절차

♣ 격리 시작 시 격리 절차 ♣

1. 격리 시작 시 절차

♦ 본원은 공기격리 또는 역격리가 필요한 경우 격리실(음압/양압)이 없으므로 다음의 절차를 따라 격리환자를 관리한다.

♦ 입원환자 중 감염성 질환이 의심되거나 발견된 경우 일인실로 이동한다.

♦ 추후 완치가 불가피한 경우 상급병원으로 전원 처리한다.

2. 격리가 필요한 감염성 질환

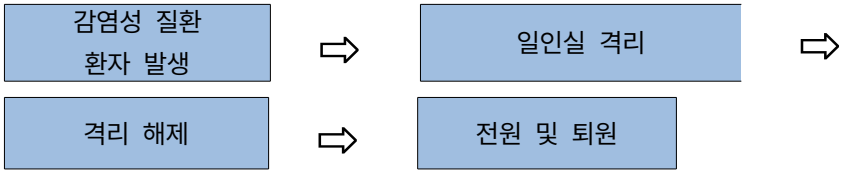
♦ 접촉주의 감염병

♦ 공기매개주의 감염병

♦ 비말주의 감염병

♦ 기타 및 주치의가 필요하다고 판단하는 경우

3. 전원시 까지 질환에 따른 격리 형태를 따른다.



♣ 격리 시작 시 부서별 역할 ♣

1. 담당의사의 역할

♦ 담당의사는 환자 상태를 고려하여 아래와 같이 적절한 격리를 한다.

•진단 확정 전: 경험적 예방조치가 필요한 경우에는 임시로 격리한다.

•공기주의/비말주의/접촉주의 중 해당사항을 적용한다.

♦ 격리의 시작과 해지 시 처방지시를 내린다.

2. 간호사의 역할

♦ 격리 환자 발생 시 타 병원으로 전원 전까지 즉각적으로 각 부서에 통보 후 격리실로 환자를 이동 시킨다.

♦ 격리 시 환자 또는 보호자에게 격리의 사유와 방법 및 전원에 대해 설명하고 주의사항에 대하여 교육을 한다.

♦ 격리에 필요한 물품을 준비한다.

♦ 격리조치에 따른 마스크, 장갑, 가운의 사용을 숙지한다.

3. 원무과 역할

♦ 격리내용을 병동간호사로부터 확인 후 전원필요시 격리실이 있는 3차 병원의 입원을 알아본다.
또한 보호자가 지정하는 병원으로 전원 시킬 수 있다.

4. 감염관리 담당자 역할

♦ 병원 직원 예방 교육

♦ 감염관리 지도 및 감독

♦ 신고 방법: 법정 감염병으로 새롭게 진단 받은 환자는 법정 전염병 신고 양식 및 절차에 의하여 보건소에 바로 신고한다.

유행감염병 의심환자 내원/발생 시 업무절차

외래/병실에서 유행 감염병 의심환자 발생

↓

의 사 : 격리 처방 및 환자에게 격리 조치에 대하여 설명

EMR에 해당 격리주의 등록

↓

간호사 : -격리실 준비(격리표지부착, 개별 물품 준비)

-격리형태에 따른 주의사항 환자.보호자에게 설명

-격리형태에 따른 감염지침 준수

↓

의 사 : 격리해제 처방 혹은 전원 및 퇴원

↓

간호사 : 격리해제, 병실청소 및 소독 관리

부록6. 보호구 착용지침

보호구 착용 지침

착용순서: 가운 입기 →마스크 착용 →보안경 착용 →장갑 착용

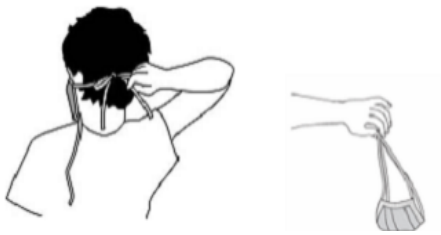
벗는 순서: 장갑 벗기 →보안경 벗기 →가운 벗기 →마스크 벗기

보호 장구 사용법

1. 마스크 사용방법



① 마스크를 착용 할 때에는 입과 코를 완전히 가리며, 코 부위가 들뜨지 않도록 모양을 잡아준다.



① 마스크를 벗을 때에는 목 부분의 끈을 먼저 푼 다음 머리 부분의 끈을 푼다.

② 겉면을 손으로 만지지 않도록 주의하며 벗은 뒤 손 위생을 한다.

2. KF94 마스크 착용방법



① 마스크와 안면 모양에 맞추어 착용한다. (마스크의 끈 중 윗부분은 머리 뒤 로, 아래 부분은 목뒤에 둔다).

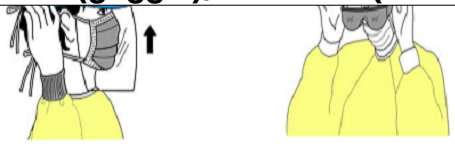
② 마스크와 안면 사이 틈새로 공기가 새는지 확인한다.



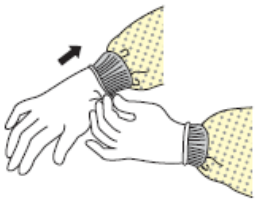
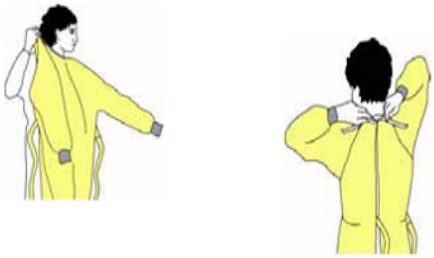
① 고정 끈을 머리 위로 올려 벗는다.

② 겉면에 손이 닿지 않게 주의하여 벗은 뒤 손 위생을 한다.

3. 고글(goggle)/ 안면가리개(face shield) 사용방법



① 고글(goggle), 안면가리개(Face Shield)는 환자의 치료나 간호 행위 중에 혈액, 체액, 분비물, 배설물 등이 튈 것이 우려되면 눈, 코, 입의 점막을 보호하기 위하여 착용한다.

	② 고글이나 안면가리개를 벗을 때는 앞면을 만지지 않고 조심하여 벗는다.
4. 장갑 사용방법	
	① 일회용 장갑은 재사용하지 않는다. ② 장갑 착용 전, 후에는 손 위생을 한다. ③ 같은 환자에게 사용하더라도 오염부위에서 청결부위로 이동할 때는 장갑을 교환한다. ④ 격리실에서 착용한 경우 병실을 나가기 직전에 벗고, 다인용 병실에서 사용한 경우는 접촉한 환자 주변에서 벗는다. ⑤ 무균술이 필요한 경우에는 무균적인 방법으로 착용한다.
	① 장갑을 벗을 때는 장갑 표면과 접촉하지 않도록 주의하면서 벗는다.
5. 일회용 비닐앞치마/비닐 가운 사용방법	
	① 일회용 비닐앞치마/가운은 재사용하지 않는다. ② 환자와 접촉면의 넓거나 오염물이 많은 경우 소매 있는 가운을 착용하고 그 외의 경우에는 비닐 앞치마를 착용한다.
	① 가운을 벗을 때에는 오염된 바깥부분이 안쪽으로 오도록 말아서 주변 환경을 오염시키지 않도록 주의하여 버린다. ② 격리실에서 착용한 경우 병실을 나가기 직전에 벗고, 다인용 병실에서 사용한 경우는 접촉한 환자 주변에서 벗는다.